

암검진 결과 판정기준

암종	판 정 구 분		판 정 기 준
공통	기존 암환자		위·간·대장·유방·자궁경부·폐암환자로 치료 중이거나 재발하지 아니한 경우
위암	이상소견없음 또는 위염		검사결과 이상소견이 없거나, 위염만 있는 경우
	양성질환		양성병변이지만 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우
	위암의심		위암이 의심되어 단기간 내 추적검사가 필요한 경우 ※ 조직진단 중 고도샘종 또는 이형성인 경우 포함
	위암		(병리)조직진단결과 신규 또는 재발한 위암환자로 즉시 치료가 필요한 경우
	기타 ()		위암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 ※ 암검진 결과기록지의 검사결과 ‘관독소견, 관찰소견’의 ‘기타’ 소견이 있을 경우 그대로 기입
간암	간암의심 소견 없음		검사결과 간암 관련 이상소견이 없는 경우
	추적검사 요망 (3개월 이내)		검사결과 이상소견이 있어 3개월 이내 추적검사가 필요한 경우 ※ 검사결과 AFP 수치는 정상범위이나 1cm 미만의 새로운 고형종괴가 발견된 경우 또는 AFP 수치가 정상범위를 초과 하지만 초음파상 간암 의심 소견은 없는 경우
	간암의심 (정밀검사요망)		검사결과 간암이 의심되어 확진검사를 위해 즉시 정밀검사가 필요한 경우 ※ 검사결과 AFP 수치가 정상범위를 초과하고 1cm 미만의 고형종괴가 있는 경우, AFP 수치와 관련없이 1cm 이상 고형종괴, 간문맥 혹은 간 정맥 혈전, 담관확장 중 하나라도 있는 경우
	기타 ()		간암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 추적검사가 필요한 경우 ※ 암검진 결과기록지의 검사결과 ‘관찰소견’에서 ‘기타’ 소견이 있을 경우 그대로 기입(간 이외에 발생한 암종의 경우 기타로 기입)
대장암	분변 잠혈 검사	잠혈반응 없음	분변잠혈검사결과 음성 판정을 받은 경우
		잠혈반응 있음	분변잠혈검사결과 양성 판정을 받은 경우
	대장 내시 경 검사 · 조직 진단	이상소견 없음	검사결과 이상소견이 없는 경우
		대장용종	대장용종이 발견되어 추가 또는 정기적인 검사나 관련 치료 후 추적관찰이 필요한 경우
		대장암 의심	대장암이 의심되어 즉시 정밀검사가 필요한 경우
		대장암	(병리)조직진단결과 신규 또는 재발한 대장암환자로 즉시 치료가 필요한 경우
		기타 ()	대장암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 ※ 암검진 결과기록지의 검사결과 ‘관독소견’ 또는 ‘관찰소견’의 항목에서 ‘기타’ 소견이 있을 경우 그대로 기입
유방암	이상소견없음		검사결과 이상소견이 없는 경우 ※ 치밀유방이면서 이상소견이 보이지 않는 경우도 여기에 해당함

암종	판 정 구 분	판 정 기 준
	양성질환	이상소견이 있으나 유방암과 관련이 없으므로 추가적인 검사가 필요 없는 경우 ※ 유방내 임파선 등 2-9번의 판독 소견이 포함되지 않는 기타 소견이 있으면 직접 기입
	유방암의심	유방암을 의심할만한 소견이 있어서 즉시 정밀검사가 필요한 경우
	판정유보	‘판정곤란’상태여서 재촬영이 필요하거나, 이상소견이 있어서 추가검사 또는 이전 검사와 비교가 필요한 경우 ※ 치밀유방이면서 이상소견이 보이지 않는 경우는 판정 유보에 해당하지 않음
자궁 경 부 암	이상소견없음	검사결과 이상소견이 없는 경우
	반응성 소견 및 감염성 질환	결과기록지의 ‘유형별진단(세포진단)’에서 ‘음성’판정이면서 추가소견이 있는 경우
	비정형 세포 이상	결과기록지의 ‘유형별진단(세포진단)’에서 가장 심각한 소견이 ‘비정형 편평상피세포(일반)’, ‘비정형 선상피세포(일반)’인 경우
	자궁경부암 전구단계 의심	결과기록지의 ‘유형별진단(세포진단)’에서 가장 심각한 소견이 ‘비정형 편평상피세포(고위험)’ 또는 ‘저등급 편평상피내 병변’, ‘고등급 편평상피내 병변’, ‘비정형 선상피세포(중양성)’, ‘상피내 선암종’인 경우
	자궁경부암 의심	결과기록지의 ‘유형별진단(세포진단)’에서 가장 심각한 소견이 ‘침윤성 편평세포암종’ 또는 ‘침윤성 선암종’인 경우
	기타()	자궁경부암과 관련이 없는 기타질환 및 소견으로 추가검사, 치료 또는 관찰이 필요한 경우 ※ 암검진 결과기록지의 검사결과 ‘유형별진단(세포진단)’에서 ‘기타’ 판정이 있을 경우 그대로 기입
폐 암	이상소견없음	폐결절이 없거나 확실한 양성(benign) 폐결절이 있는 경우 (Lung-RADS 범주 1)
	양성 결절	폐암의 가능성이 낮은 결절로 1년 후 정기검사가 필요한 경우 (Lung-RADS 범주 2)
	경계성 결절	폐결절이 양성으로 추정되지만 6개월내 추적검사가 필요한 경우 (Lung-RADS 범주 3)
	폐암 의심	폐암이 의심되어 3개월내 추적검사가 필요한 경우 (Lung-RADS 범주 4A)
	폐암 매우 의심	폐암의 가능성이 매우 높아 추가검사가 필요한 경우 (Lung-RADS 범주 4B, 4X)
	기타 (폐결절외 의미있는 소견)	폐결절 이외 폐암과 관련이 없는 폐질환 또는 기타 흉부질환 소견으로 추가검사 또는 진료가 필요한 경우

폐암검진 결과 상세 판정기준

범 주	구 분	범주	소 견	추 적 관 리
불완전		0	이전 흉부CT가 있으므로 비교가 필요함 폐의 일부 또는 전체가 관독이 어려움	이전 흉부CT와의 비교가 필요하거나 추가 폐암 검진 CT 요함
이상 소견 없음	결절이 없거나 확실한 양성 결절	1	폐결절 없음 특징적인 양성 소견 1) 결절내 석회화: 전체, 중심성, 팝콘형, 동심원형 링모양 2) 지방을 포함하는 결절	12개월 후 연례 폐암 검진CT 요함
양성 결절	임상적으로 의미 있는 폐암이 될 가능성이 매우 낮은 결절	2	흉막주변결절: 첫 검진 또는 새로 생긴 매끄러운 경계, 난형, 렌즈모양, 삼각형 모양의 평균직경 <10 mm의 고형결절	
			고형 결절: 1) 첫 검진에서 <6 mm 2) 새로 생긴 <4 mm	
			부분고형 결절: 첫 검진에서 <6 mm	
			간유리 결절: 1) 첫 검진, 새로운 또는 커진 <30 mm 또는 2) ≥30 mm이며 크기 변화 없거나 서서히 커짐	
			기도 결절: 세분절에 위치하거나 분비물	
			범주 3 결절로 6개월 추적 검사에서 변화 없거나 감소 범주 3 또는 4A 결절로 추적 검사에서 없어짐 범주 4B 결절로 적절한 진단검사를 통해 양성원인으로 증명됨	
		2b	범주 3,4에 해당되나 양성 가능성이 높은 영상 소견을 보이는 경우	
경계성 결절	양성의 가능성이 있지만 추적 검사가 필요함	3	고형 결절: 1) 첫 검진에서 ≥6 mm에서 <8 mm 또는 2) 새로 생긴 ≥4 mm에서 <6 mm인 결절	6개월 후 저선량 CT
			부분고형 결절: 1) 전체 직경이 ≥6 mm으로 고형부분이 <6 mm 2) 전체 직경이 < 6 mm의 새로 생긴 결절	
			간유리 결절: 첫 검진에서 ≥30 mm 또는 새로 생긴 결절 ≥30 mm	
			비정형 폐낭종: 두꺼운 벽을 갖는 낭종에서 낭성 성분이 커진 경우 (평균직경)	
			범주 4A 결절로 3개월 추적 검사에서 변화 없거나 크기가 감소 (기도 결절 제외)	
폐암 의심	추가검사가 필요한 결절	4A	고형결절: 1) 첫 검진에서 ≥8 mm에서 <15 mm 2) 커진 < 8 mm 3) 새로 생긴 ≥6 mm에서 < 8 mm	◦3개월 후 저선량흉부 CT: 8 mm이상의 고형부분이 있는 결절일 경우 PET/CT 시행할 수 있음

범 주	구 분	범주	소 견	추 적 관 리
			부분고형 결절: 1) ≥ 6 mm 결절로 고형부분 ≥ 6 mm에서 < 8 mm 2) 새로 생긴 또는 커진 고형부분이 < 4 mm의 결절 기도 결절: 분절 또는 근위부에 위치. 첫 검진 또는 새로 생긴 비정형 폐낭종: 1) 두꺼운 벽의 낭종 2) 첫 검진에서 다방성 낭종 3) 다방성으로 변한 얇은 벽 또는 두꺼운 벽의 낭종	◦ 기도결절인 경우, 호흡기내과 진료 후 기관지내시경 검사를 시행할 수 있음
폐암 매우 의심	추가검사나 조직검사가 필요한 결절	4B 4X	기도 결절, 분절 또는 근위부에 위치. 변화 없거나 커짐 고형결절: 1) ≥ 15 mm 2) 새로 생긴 또는 커진 ≥ 8 mm 결절 부분고형 결절: 1) ≥ 8 mm 고형부분을 가진 2) 새로 생긴 또는 커진 고형부분이 ≥ 4 mm의 결절 비정형 폐낭종: 1) 벽 두께/ 결절성분이 커지는 두꺼운 벽의 낭종 2) 커진 다방성 낭종 (평균 직경) 3) 다방성 낭종으로 방이 증가하거나 새로운/증가하는 음영 (결절, 간유리, 폐경결)을 동반함 수차례 검진에 걸쳐 서서히 커지는 고형 또는 부분고형 결절 범주 3, 4 결절로 악성의 가능성이 높은 영상 소견을 보이는 경우	◦ 조영증강 또는 비조영증강 흉부 CT ◦ 8 mm 이상의 고형부분이 있는 결절일 경우 PET/CT 시행할 수 있음 ◦ 악성의 가능성과 동반질환을 고려하여 조직검사.
기타 (결절외 의미있 는 소견)	폐암이 아니나 임상적으로 의미 있는 병변	S	수식어로 범주 0-4 코드에 추가할 수 있음	소견에 맞게 조치, 관리
폐암 병력	과거 폐암병력	C	수식어로 범주 0-4 코드에 추가할 수 있음	